



НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(НСЗУ)

просп. Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073, тел.: (044) 426-67-77, (044) 290-06-91

E-mail: info@nszu.gov.ua, сайт: www.nszu.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 42032422

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

Професійна спілка працівників
охорони здоров'я України

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) розглянула лист від 16.03.2026 № 03-03/58 (вх. НСЗУ № 6354-16-26 від 19.03.2026) щодо проблемних питань взаємодії надавачів медичних послуг з НСЗУ та в межах компетенції повідомляє.

Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Правові засади діяльності НСЗУ визначені, зокрема Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та Положенням про Національну службу здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1101 (далі – Положення).

Відповідно до пункту 1 Положення, НСЗУ є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

Відповідно до пункту 3 Положення, основним завданням НСЗУ є, зокрема, реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (програма медичних гарантій).

На виконання покладених завдань, відповідно до підпунктів 4, 5, 51 та 9 пункту 4 Положення, НСЗУ:

укладає, змінює та припиняє договори про медичне обслуговування населення та договори про реімбурсацію;

здійснює заходи, що забезпечують цільове та ефективне використання коштів за програмою медичних гарантій;

проводить моніторинг виконання умов договорів про медичне обслуговування населення та про реімбурсацію у порядку, встановленому законодавством;

здійснює оплату згідно з тарифом за надані пацієнтам медичні послуги (включаючи медичні вироби) та лікарські засоби за договорами про медичне



обслуговування населення за програмою медичних гарантій та іншими договорами про медичне обслуговування населення.

Дякуємо за надану позицію та ґрунтовний аналіз практичних аспектів реалізації програми медичних гарантій, зокрема в частині забезпечення фінансової стабільності закладів охорони здоров'я та дотримання трудових прав працівників галузі.

Щодо впровадження нових алгоритмів автоматичного моніторингу у 2025 році.

НСЗУ у 2025 році відповідно до покладених на неї завдань, з метою забезпечення цільового та ефективного використання коштів за програмою медичних гарантій, було проведено планові та позапланові моніторинги виконання надавачами медичних послуг умов Договорів.

В доповнення до вже діючих алгоритмів автоматичного моніторингу, НСЗУ було впроваджено нові алгоритми автоматичного моніторингу, здійснено автоматичний моніторинг, зокрема за пакетами медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня», «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям» та «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» шляхом проведення аналізу електронних медичних записів (далі – ЕМЗ), внесених до електронної системи охорони здоров'я (далі – ЕСОЗ) надавачами медичних послуг, та виявлено факти внесення ЕМЗ, що містять недостовірну та/або неповну інформацію про діагнози та/або проведені пацієнтам інтервенції, та/або необґрунтоване лікування пацієнта.

За результатами автоматичного моніторингу ЕМЗ за новими алгоритмами автоматичного моніторингу виявлено численні та систематичні випадки зловживань щодо внесення до ЕМЗ ймовірно недостовірних діагнозів та інтервенцій з метою віднесення таких медзаписів до діагностично-споріднених груп (далі - ДСГ) з більш високими ваговими коефіцієнтами.

За результатами автоматичного моніторингу окремі ЕМЗ були визнані такими, що потребують перегляду з наступним віднесенням до відповідної ДСГ та пакету медичних послуг або такими, що не відповідають критеріям повноти і достовірності та не підлягають оплаті.

Повідомляємо, всі перерахунки за результатами автоматичного моніторингу здійснювались в межах року. Нові алгоритми не застосовуються на медичні записи попередніх років, це також стосується коригування вартості та формування нових звітів. НСЗУ не здійснює перерахунки за попередніми періодами, тому порушене питання не потребує додаткового врегулювання.

Водночас, слід зазначити, що нові алгоритми впроваджені в рутинні процедури визначення належності записів про надані медичні послуги, внесених до ЕСОЗ та визначення відповідності критеріям повноти та достовірності медичних записів, що віднесені до пакетів медичних послуг за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та іншими договорами, що діють у 2026 році.

Щодо результатів перевірки зареєстрованого медичного персоналу вимогам умов закупівлі, та здійснення верифікації основного місця роботи.

Інформуємо, що починаючи з 2023 року НСЗУ щоденно здійснює автоматичний моніторинг відповідності надавачів медичних послуг умовам закупівлі за відповідним пакетом медичних послуг, зокрема в частині зареєстрованого медичного персоналу. У разі виявлення невідповідності кількості медичного персоналу – медичні послуги, надані в періодах, протягом яких були виявлені такі невідповідності, не підлягатимуть оплаті за пакетом медичних послуг, по якому виявлено такі невідповідності (включно й за пакетами, фінансування за якими здійснюється на основі глобальної ставки).

Процедура перевірки полягає у:

встановленні мінімальної кількості необхідного медичного персоналу, яка повинна бути у надавача медичних послуг (з урахуванням вимог умов закупівлі);

визначенні наявної кількості медичного персоналу (унікальних записів про осіб, що містяться в Реєстрі медичних спеціалістів (далі - Реєстр) центральної бази даних ЕСОЗ та перебувають у трудових відносинах з надавачем медичних послуг, записи яких є активними станом на дату перевірки);

порівнянні наявної кількості медичного персоналу надавача медичних послуг з мінімальною кількістю персоналу, яка повинна бути у надавача медичних послуг.

Оскільки в системі відсутня можливість ідентифікувати медичного працівника за основним місцем роботи та/або за сумісництвом, реєстрація одного медичного працівника в різних закладах охорони здоров'я може свідчити про те, що окремими надавачами медичних послуг можуть не виконуватись вимоги до кількості та спеціалізації медичного персоналу, який працює в закладі за основним місцем роботи, в межах необхідної для надання медичних послуг за Договором кількості персоналу.

Повідомляємо, що за результатами перехресної перевірки інформації, яка міститься в системі, щодо внесення інформації про медичний персонал усіх надавачів медичних послуг встановлено, що окремий(-і) працівник(-и) надавача медичних послуг працевлаштовані в декількох надавачів медичних послуг, та враховані при оцінці відповідності умовам закупівлі щодо мінімальної кількості персоналу, які працюють на відповідних посадах за основним місцем роботи.

Встановлені факти працевлаштування одного медичного працівника в різних закладах охорони здоров'я можуть свідчити про те, що окремими надавачами медичних послуг не виконуються вимоги до кількості та спеціалізації медичного персоналу, який працює в закладі за основним місцем роботи, в межах необхідної для надання медичних послуг за Договором кількості персоналу.

Відповідно до частини другої статті 21 Кодексу законів про працю України, працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Пунктом 12 частини першої статті 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» передбачено, що основне місце роботи – місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору, та визначене ним як основне згідно з поданою заявою (до відкликання) та відомостями, що обліковуються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру на її підставі.

Відтак, враховуючи неможливість працевлаштування особи за основним місцем роботи у декількох надавачів медичних послуг одночасно, з метою перевірки належного виконання умов Договору НСЗУ провела додаткову верифікацію працевлаштування медичного персоналу направивши запит листом від 18.02.2025 № 5140/5-15-26. Надавачі медичних послуг мали надати запитувану інформацію до 27.02.2026 (включно) відповідь надсилати на електронну адресу НСЗУ info@nszu.gov.ua з супровідним листом.

НСЗУ зупинила оплату 11.03.2026 24 надавачам медичних послуг, але не через наявність медичних працівників за сумісництвом, а через те що надавачами не було надано запитувану інформацію у повному обсязі до 27.02.2026 на запит № 5140/5-15-26 від 18.02.2025.

Після отримання відповіді - оплати були відновлено протягом 1-2 днів з моменту отримання повної відповіді, відновлення оплати останньому надавачу медичних послуг відбулося 17.04.2026.

Отримана інформація за результатами верифікації була врахована в межах перевірки зареєстрованого медичного персоналу, після чого було здійснено оновлений розрахунок наявної кількості медичного персоналу надавачів за позиціями перевірки з урахуванням отриманої інформації, та відповідно скоригована оцінка відповідності надавачів умовам закупівлі медичних послуг за договорами про медичне обслуговування населення у розрізі пакетів медичних послуг у частині вимог до персоналу. За результатами ініціативи, в окремих надавачів медичних послуг виявлено невідповідності щодо мінімальної кількості персоналу, та здійснено перерахунку за періоди невідповідності.

У підсумку, НСЗУ не створює імперативні обмеження роботи за сумісництвом, зокрема кількість роботодавців, у яких особа може працювати за сумісництвом, а здійснювала заходи щодо верифікації інформації про трудові відносини з медичними працівниками для здійснення перевірки відповідності вимогам до медичного персоналу умов закупівлі.

Щодо здійснення фінансового моніторингу та перерахунків повідомляємо, що НСЗУ здійснює фінансовий моніторинг та, у передбачених чинним законодавством випадках, фінансові перерахунки в межах виконання функцій замовника медичних послуг з метою забезпечення цільового використання коштів програми медичних гарантій, дотримання умов договорів про медичне обслуговування населення, застосування єдиних підходів до оплати медичних послуг.

Оплата медичних послуг за програмою медичних гарантій у 2026 році здійснюється відповідно до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2026 році, затвердженим постановою

Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2025 р. № 1808 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2026 році» (далі - Порядок). Умови закупівлі медичних послуг, порядок оплати та застосування коригувальних коефіцієнтів визначаються зазначеним Порядком та договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

НСЗУ здійснює оплату надавачам медичних послуг, в межах строку діючого договору, відповідно до умов укладених договорів, фактичного обсягу наданих медичних послуг та інформації, внесеної до електронної системи охорони здоров'я (далі – ЕСОЗ). Відповідно, обсяг фінансування закладу охорони здоров'я може залежати, зокрема, від структури та обсягів наданої медичної допомоги, а також повноти та коректності внесених електронних медичних записів (далі - ЕМЗ).

Обсяг закупівлі медичних послуг та фінансування на 2026 рік формувався з урахуванням аналізу фактичних обсягів надання медичної допомоги, структури звернень пацієнтів, даних ЕСОЗ, а також прогнозованої оцінки потреб населення у відповідних видах медичних послуг.

Щодо питання скасування будь-яких понижуючих коефіцієнтів повідомляємо, що у рамках реалізації програми медичних гарантій не передбачені понижуючі коефіцієнти.

Для певної частини пакетів медичних послуг НСЗУ застосовує формульний або капітаційний підхід до розрахунку оплати. Такий підхід передбачає використання базової ставки або глобальної/капітаційної ставки з подальшим коригуванням залежно від складності, типу втручання, ресурсоемності, віку пацієнта або технології надання допомоги. Це відповідає міжнародно визнаній практиці стратегічних закупівель медичних послуг.

Водночас звертаємо увагу, що зміна обсягів фінансування окремих надавачів медичних послуг у 2026 році обумовлена застосуванням єдиних для всіх закладів правил оплати та коригувальних коефіцієнтів, визначених Порядком. Зокрема, до окремих надавачів могли бути застосовані відповідні коригувальні коефіцієнти у разі невідповідності встановленим вимогам щодо структури надання медичних послуг, рівня маршрутизації пацієнтів, частки направлень від лікарів первинної медичної допомоги, забезпечення комплексності амбулаторної допомоги, обсягів лабораторних та інструментальних досліджень, фактичного надання медичної допомоги при ургентних (невідкладних) станах, а також у разі перевищення встановлених порогових значень частки випадків лікування пацієнтів з амбулаторно-асоційованими станами та/або амбулаторно-асоційованими інтервенціями за пакетами, передбаченими відповідними главами Порядку реалізації програми медичних гарантій.

Зазначене свідчить про наявність у окремих надавачів структурного перекосу у моделі надання медичної допомоги, зокрема заміщення стаціонарної, спеціалізованої або невідкладної допомоги випадками, які за своєю клінічною та організаційною суттю повинні надаватися в умовах стаціонару одного дня або в

межах амбулаторного маршруту пацієнта, що і стало підставою для застосування відповідних коригувальних коефіцієнтів.

При цьому вищезазначені підходи є уніфікованими та застосовуються однаково до всіх надавачів медичних послуг, крім прямо визначених нормативно-правовим актом окремих профілів закладів з урахуванням особливості їх діяльності в наданні медичної допомоги, зокрема онкологічного, інфекційного, фтизіатричного, психіатричного, акушерського, кардіологічного та нейрохірургічного напрямів. Такий підхід спрямований на забезпечення належної структури та комплексності надання медичної допомоги, дотримання затверджених маршрутів пацієнта, а також недопущення заміщення спеціалізованої, стаціонарної або невідкладної допомоги послугами амбулаторного рівня поза визначеними умовами закупівлі та умовами укладених договорів.

Щодо пропозиції поширити підвищений рівень оплати праці, передбачений пунктом 186 глави 43. «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на територіях бойових дій» Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2026 році, на посади професіоналів у сфері охорони здоров'я (цитоморфологів, вірусологів, біохіміків, та інших професіоналів медико-лабораторного профілю) зазначаємо, що НСЗУ забезпечує реалізацію програми медичних гарантій у межах і способ, визначених законодавством. Водночас питання перегляду механізмів оплати медичних послуг належить до сфери нормативно-правового регулювання та не можуть бути вирішені НСЗУ в індивідуальному порядку.

НСЗУ діє виключно в межах чинного нормативного регулювання та відповідно до умов реалізації програми медичних гарантій у 2026 році.

Пріоритет діяльності НСЗУ – ефективна реалізація програми медичних гарантій в інтересах пацієнтів, доступне та належне лікування кожного пацієнта.

Голова

Наталія ГУСАК